SALUD PÚBLICA · NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Hábitos alimentarios saludables en la población adulta

Plan de intervención en la Urbanización Britania, Cartagena de Indias. Prevención primaria a partir de una encuesta a 27 adultos.

Camila Aguas Morales
Luis Fernando Bertel
Yorgeth Figueroa Hernández
Karen Meléndez Rodriguez
Camila Benavides
David Carmona Rivero
Rosa Madrid Negrete
Zharick Rodríguez Arbelaez

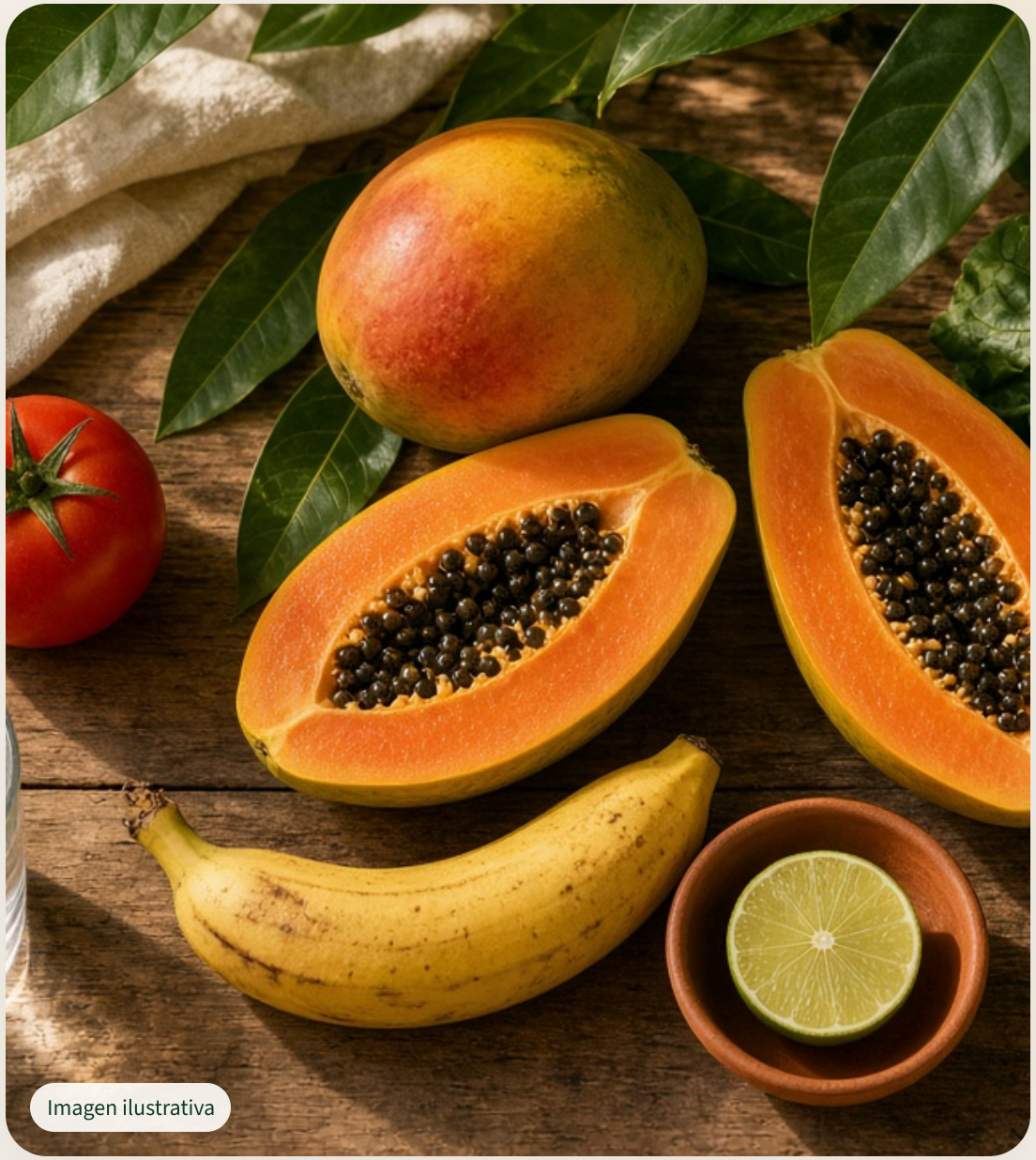


Imagen ilustrativa

Cartagena, 28 de octubre

EN UNA MIRADA

Lo que el informe deja listo para contar

PROBLEMA

Comidas rápidas, ultraprocesados y bebidas azucaradas, con pocas frutas y verduras. Eso eleva el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.

LÍNEA BASE

Encuesta en línea a 27 personas. El 74,1 % come ninguna o una porción de verduras al día y el 40,7 % no come fruta a diario.

RESPUESTA

Educación alimentaria y nutricional, menús económicos y organización del tiempo. Prevención primaria, antes de que aparezca la enfermedad.

LO QUE FALTA MEDIR

Las metas SMART están definidas. La segunda encuesta, la del “después”, todavía no aparece en el informe.



Imagen ilustrativa · fresco frente a ultraprocesado

1 · DIAGNÓSTICO

Intervenir ahora, mientras el hábito todavía se puede cambiar

La alimentación inadecuada es un riesgo modificable de exceso de peso, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular.

400 g

Mínimo diario de frutas y verduras que recomienda la OMS, cerca de cinco porciones, para prevenir las ECNT.

56,4 %

De los adultos colombianos tenía exceso de peso en la ENSIN 2015. El problema ya es nacional.

Ninguna

Persona de Britania llegaba a tres porciones de fruta. Solo el 25,9 % comía dos o más porciones de verduras.

La población encuestada es joven: el 85,2 % tiene entre 18 y 29 años. Cambiar el hábito en esta etapa evita que se consolide antes de la enfermedad.

LÍNEA BASE · N = 27

Una comunidad joven, estudiante y de estratos bajos

63 %

Mujeres. Hombres: 37 % (10 personas).

85 %

Entre 18 y 29 años. Hay 2 personas de 40–49 y 2 de 50–59.

59 %

Estudiantes. Empleados: 22,2 %. Otras situaciones: 18,5 %.

89 %

Estratos 1 a 3. El 66,6 % vive en estrato 1 o 2.

EDUCACIÓN

Universitaria 48,1 %, secundaria 25,9 %, técnica 18,5 % y posgrado 7,4 %.

INGRESO DEL HOGAR

El 66,6 % llega hasta dos salarios mínimos. El 33,3 % está por debajo de un salario.

HOGAR

El 59,3 % vive con 2 o 3 personas. El 33,3 % vive en hogares de 4 o 5.

Tabla 1 del informe. Encuesta propia, formulario en línea, Urbanización Britania.

LO QUE COME HOY

La distancia frente a una alimentación saludable

40,7 %

No consume ninguna porción de fruta al día. El 51,9 % consume solo una.

74,1 %

Come ninguna o una porción de verduras. Solo el 25,9 % llega a dos o más.

88,9 %

Consume ultraprocesados de 1 a 4 veces por semana. El 7,4 % los come a diario.

55,5 %

Bebe menos de 1,5 litros de agua al día. El 63 % sí hace tres tiempos de comida.



Imagen ilustrativa · agua y fruta

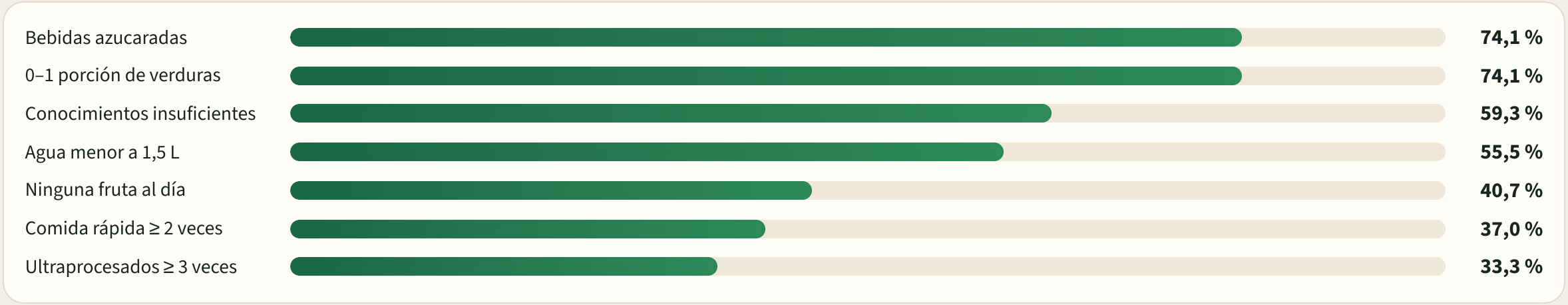
TAMBIÉN EN LA SEMANA

Comida rápida 2 o más veces: 37 %. Comer fuera 1 o 2 veces: 66,7 %. Bebidas azucaradas al menos algunas veces: 74,1 % (51,9 % algunas veces y 22,2 % frecuente).

Tabla 2 y sección 5.1. No mezclar “1 a 4 veces por semana” (88,9 %) con “3 o más veces” (33,3 %): miden cortes distintos.

FIGURA 1 DEL INFORME

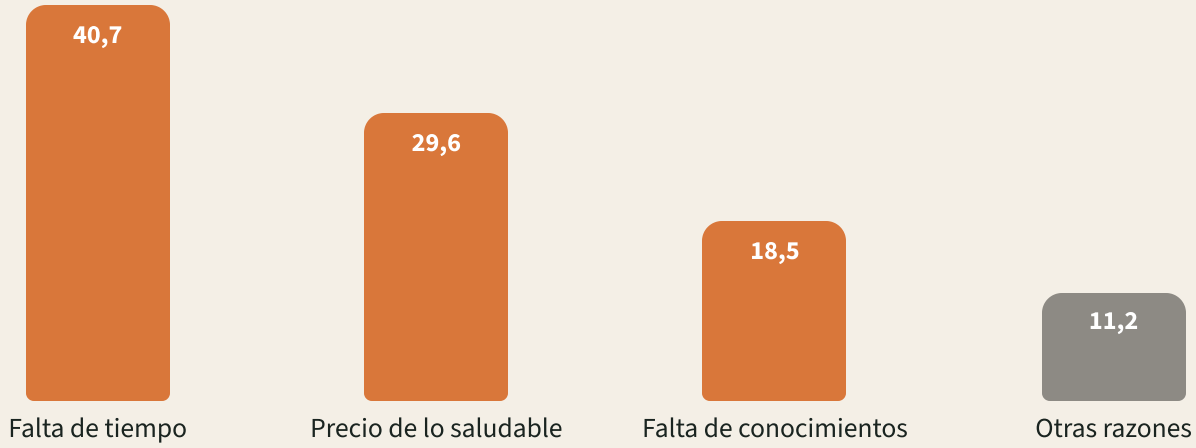
Los siete riesgos que el grupo priorizó



Porcentaje de participantes (n = 27). La barra usa la misma escala del informe, de 0 a 90. Bebidas azucaradas: algunas veces o frecuente.

FIGURA 2 · PRINCIPAL DIFICULTAD

El tiempo pesa más que el precio, y el precio pesa mucho



Escala de 0 a 50, como en la figura original. Suma 100 %: cada persona marcó una dificultad principal.


Imagen ilustrativa · tiempo y costo

EL PRECIO, CON OTRA PREGUNTA

El 29,6 % dice que el costo dificulta siempre el consumo de alimentos saludables y el 37,0 % que lo dificulta algunas veces. Juntos, 66,6 %.

LO QUE YA SE PUEDE AFIRMAR

Saber no basta, y casi todos quieren participar

59,3 %

Se percibe sin conocimientos suficientes sobre alimentación saludable. Meta: bajar a 30 % o menos.

51,9 %

Ya había recibido orientación. La información aislada no cambió el hábito: hace falta práctica.

88,9 %

Dijo que sí participaría (59,3 %) o que tal vez (29,6 %). Es la mayor fortaleza del proyecto.

Impacto ya observable. El informe no trae la medición de seguimiento. Lo que sí está logrado es el diagnóstico, la priorización y una disposición alta para los talleres.

2 · OBJETIVOS SMART

Una meta general y cinco cambios medibles

Promover hábitos saludables en los adultos de Britania, con educación alimentaria y nutricional, para reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Qué cambiar	Hoy	Meta al cerrar los talleres
Quienes se sienten sin conocimientos suficientes	59,3 %	≤ 30 %
Sin fruta a diario / con 0–1 porción de verduras	40,7 % · 74,1 %	≤ 20 % · ≤ 50 %
Bebidas azucaradas / ultraprocesados ≥ 3 veces por semana	74,1 % · 33,3 %	≤ 50 % · ≤ 20 %
Agua menor a 1,5 litros al día	55,5 %	≤ 30 %
Asistir a mínimo 2 de 3 sesiones y elaborar un menú económico	Proceso	≥ 80 %

Tabla 3. Cada meta tiene indicador, línea base y plazo: el cierre del ciclo de talleres.

3 · METODOLOGÍA

Prevención primaria, en seis pasos

1. Elegir el problema y el lugar: hábitos poco saludables en adultos de la Urbanización Britania.
2. Diseñar y aplicar la encuesta en línea. Respondieron 27 personas.
3. Tabular y priorizar: frutas, verduras, tiempo, precio y conocimientos.
4. Diseñar el programa según el presupuesto, el tiempo y los alimentos disponibles.
5. Hacer los talleres, los menús económicos y la orientación de horarios.
6. Volver a aplicar el cuestionario y dejar recomendaciones de continuidad.



Imagen ilustrativa · taller de preparación

NIVEL DE PREVENCIÓN

Personas aparentemente sanas. Se actúa sobre el riesgo antes de la enfermedad, con educación para la salud en el marco de la Carta de Ottawa. La encuesta también identifica riesgos.

LO QUE SE PONE EN PRÁCTICA

Talleres cortos, visuales y con comida real

EN EL TALLER

Porciones de frutas y verduras, menús saludables y económicos, comidas rápidas de preparar, más agua y menos bebidas azucaradas y ultraprocesados.

POR QUÉ ASÍ

El 40,7 % no tiene tiempo, el precio es la segunda barrera y la mayoría tiene entre 18 y 29 años. El mensaje tiene que ser breve, práctico y barato.

MATERIAL DE REFERENCIA

Guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años (ICBF y Ministerio de Salud, 2020). La presentación de clase se apoyó en material visual de porciones y en guías de menú.

Humanos, instrumentos, material educativo, alimentos de demostración y tecnología. Tabla 4 del informe.

8 estudiantes facilitadores **Encuesta y asistencia** **Guías alimentarias colombianas**
Frutas, verduras y agua **Celulares y computadores**

4 · SISTEMA DE EVALUACIÓN

Proceso para saber si se hizo. Impacto para saber si cambió.

PROCESO

Cobertura: participantes sobre convocados. Meta ≥ 80 %.

Sesiones hechas sobre sesiones planeadas. Meta 100 %.

Menús saludables y económicos elaborados. Meta ≥ 80 % de quienes asisten.

IMPACTO, DEL ANTES A LA META

Conocimientos insuficientes: 59,3 % → ≤ 30 %.

Sin fruta diaria: 40,7 % → ≤ 20 %. Verduras 0–1: 74,1 % → ≤ 50 %.

Bebidas azucaradas 74,1 % → ≤ 50 %. Ultraprocesados ≥ 3/semana: 33,3 % → ≤ 20 %.

Agua < 1,5 L: 55,5 % → ≤ 30 %.

Mismo cuestionario antes y después, preguntas de frecuencia, barreras e interés, y registro de asistencia. Así el cambio se puede comparar.

FIGURA 3 · NO ES UN RESULTADO MEDIDO

De la línea base a la meta esperada

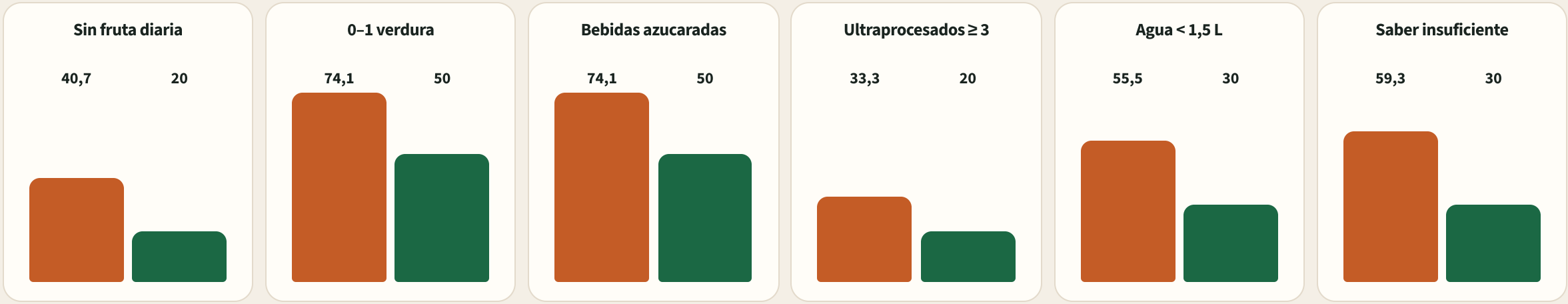


Tabla 6. La columna de seguimiento del informe dice “por medir” en los seis indicadores.

5 · CUMPLIMIENTO

La fórmula ya está. El segundo dato, no.

Porcentaje de cumplimiento

(antes − después) / (antes − meta) × 100

Si quien no come fruta a diario bajara de 40,7 % a 25 %, el cumplimiento sería (40,7 − 25) / (40,7 − 20) × 100 = 75,8 %. Llegar a 100 % o más significa que la meta se cumplió.

CÓMO LEERLO EN LA SUSTENTACIÓN

No decir que los hábitos ya mejoraron. Decir que el diagnóstico justificó la intervención y que el cuestionario se vuelve a aplicar al cerrar.

Con 27 personas el resultado es descriptivo. No representa a toda la urbanización. El informe recomienda ampliar la recolección.

6 · DISCUSIÓN

El plato también lo decide el entorno

DINERO

El 66,6 % de los hogares llega hasta dos salarios mínimos y el 66,6 % está en estrato 1 o 2. El precio dificulta siempre o a veces al 66,6 %.

EDUCACIÓN

El 59,3 % reconoce vacíos, aunque el 51,9 % ya recibió orientación. Hace falta acompañar la práctica, no solo informar.

TIEMPO

Estudio y trabajo dejan poco margen para cocinar. Por eso ganan la comida rápida y la comida preparada.

OFERTA

Lo ultraprocesado suele ser más barato y más fácil de conseguir que la fruta y la verdura.

LECCIONES QUE YA AJUSTARON EL TALLER

Organizar horarios y preparar comidas rápidas, porque el tiempo fue la barrera principal.

Proponer menús con alimentos accesibles, porque el precio fue la segunda.

Hablar breve, práctico y visual, porque la audiencia es joven.

No generalizar: 27 casos describen a quienes respondieron.

Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, OMS, 2009. Las condiciones en que se nace, vive, estudia y trabaja condicionan el hábito.

PARA QUE NO SE QUEDE EN UN CICLO

Cinco formas de sostener el cambio



Imagen ilustrativa · huerta y mercado fresco

1. Formar promotores voluntarios que sigan con los talleres.
2. Articular la Junta de Acción Comunal, los colegios y el centro de salud cercano.
3. Abrir huertas, mercados frescos o compras colectivas para bajar el precio.
4. Compartir recetarios económicos y un plan semanal por redes y mensajería.
5. Repetir los indicadores cada seis meses y ajustar lo que no se mueva.

CIERRE

Tres ideas para dejar en la sustentación

SÍ HACÍA FALTA INTERVENIR

El 74,1 % come ninguna o una verdura, el 40,7 % no come fruta a diario y casi 9 de cada 10 consumen ultraprocesados con regularidad. En gente joven, la prevención primaria llega a tiempo.

NO ES SOLO FALTA DE INFORMACIÓN

Tiempo, precio y conocimiento se cruzan con ingresos bajos y estratos 1 y 2. La educación tiene que ser práctica, económica y pegada a la rutina.

HAY CON QUIÉN CONTINUAR

El 88,9 % participaría o tal vez lo haría. Las metas y la fórmula de cumplimiento ya permiten medir el cambio cuando se aplique la segunda encuesta.

Recomendación del informe: ampliar la muestra y sostener el trabajo con líderes comunitarios e instituciones locales.

REFERENCIAS DEL INFORME

De dónde salen las cifras y los marcos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). *Guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años.* Bogotá.

Ministerio de Salud y Protección Social, ICBF y otros. (2019). *Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia 2015 (ENSIN 2015).* Bogotá.

Organización Mundial de la Salud. (2020). *Alimentación sana* [nota descriptiva].

Organización Mundial de la Salud. (1986). *Carta de Ottawa para la promoción de la salud.* Ottawa.

Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. (2009). *Subsanar las desigualdades en una generación.* OMS.

Línea base: encuesta propia del grupo en la Urbanización Britania (n = 27).

Las fotografías de esta presentación son ilustraciones. No son registros del trabajo de campo. El PDF original está en `fuente/informe-salud-publica.pdf`.